

REHABILITACIÓN EN TRAUMATOLOGÍA Y DEPORTE

SEMANA 3

LESIONES Y FRACTURAS DEL MMSS II

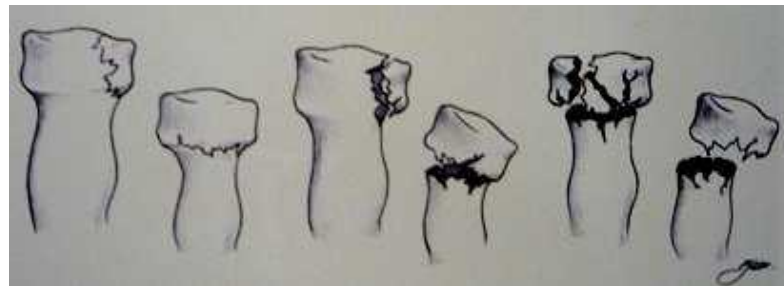


Presente.

Lic. Kevin Tejada Cuadros

FRACTURA DE CABEZA DE RADIO

- 20-30% de las fracturas del codo.
- **Mecanismo lesional:** Generalmente traumatismos indirectos al caer sobre la mano en extensión.
- **Clínica:** dolor selectivo a la palpación de la cabeza de radio, que se acentúa con la prono-supinación



CLASIFICACIÓN

GRADO I:

- Parcelar <30 % , sin desplazamiento o < 2mm.
- Pronosupinación limitada por el dolor y la tumefacción.
- No hay bloqueo articular.

GRADO II:

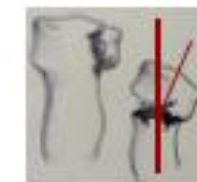
- Parcelar > 30% con desplazamiento > 2mm.
- Puede haber bloqueo mecánico de la articulación.
- Angulación >30°.

GRADO III:

- Conminuta.

GRADO IV:

- Fracturas asociadas a luxación del codo.





FRACTURA DE OLÉCRANON

MECANISMO LESIONAL:

- Impacto directo sobre el olécranon con el codo en flexión.

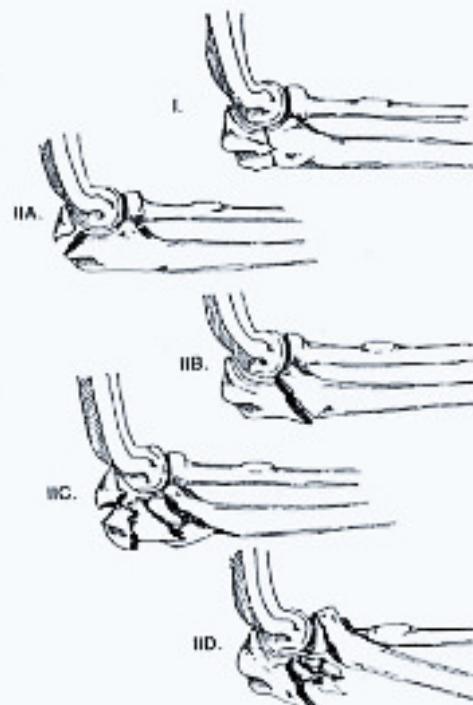
SIGNOS Y SÍNTOMAS:

- Dolor, tumefacción, edema sobre el olécranon,
- Clínica por afectación del nervio cubital.
- Palpación de un surco en el lugar de la fractura.
- Impotencia para extensión de codo contra gravedad



CLASIFICACION DE COLTON

TIPO 1	TIPO 2
Fracturas no desplazadas / desplazamiento mínimo (<2mm) con el codo en flexión 90° / extensión contra la gravedad.	Fracturas desplazadas (>2mm).
Fracturas estables y el paciente conserva su capacidad de extender activamente el codo.	2A: Fractura por avulsión 2B: Fractura transversa o oblicua 2C: Fractura luxación 2D: Fractura conminuta





FRACTURA DE COLLES

- Fractura del radio distal con desplazamiento dorsal del fragmento distal. Es una de las fracturas más frecuentes del miembro superior.
- Fractura en “tallo verde”

MECANISMO DE LESIÓN

- Caída sobre la mano extendida (FOOSH: *Fall On Outstretched Hand*).
- Muñeca en extensión.
- Más frecuente en adultos mayores con osteoporosis.



SIGNOS Y SÍNTOMAS

Dolor intenso en muñeca.

Edema e inflamación local.

Deformidad en “dorso de tenedor”.

Limitación funcional (flexo-extensión y prensión).

Posible parestesia por compromiso del nervio mediano.



TRATAMIENTO REHABILITADOR

Etapa	Objetivos	Intervenciones
Inmovilización (0-4/6 sem)	Control dolor y edema	Crioterapia, elevación, movilidad activa de dedos, hombro y codo
Post retiro de yeso	Recuperar movilidad	Movilizaciones pasivas y activas asistidas, ejercicios pendulares de muñeca
Fortalecimiento (6-8 sem)	Mejorar fuerza y prensión	Ejercicios con banda elástica, pelota terapéutica
Funcional (8-12 sem)	Reintegración laboral	Ejercicios propioceptivos y actividades funcionales





FRACTURA DE SMITH

- Fractura del radio distal con desplazamiento volar (palmar) del fragmento distal. Es considerada la “inversa” de la fractura de Colles

MECANISMO DE LESIÓN

- Caída sobre la mano en flexión
- Golpe directo sobre el dorso de la muñeca



SIGNOS Y SÍNTOMAS

Dolor e inflamación de muñeca.

Deformidad en “pala de jardín”

Limitación de movilidad

Posible lesión neurovascular





TRATAMIENTO REHABILITADOR

Etapa	Tiempo aproximado	Objetivos fisioterapéuticos	Intervenciones
Inmovilización	0-4/6 semanas	• Disminuir dolor y edema • Mantener movilidad proximal	• Crioterapia • elevación y vendaje compresivo • movilidad activa de dedos • ejercicios de hombro y codo • educación postural
Post inmovilización (movilidad inicial)	4-6 semanas	• Recuperar ROM progresivo • Evitar rigidez	• Movilizaciones pasivas y activas asistidas • ejercicios de flexión-extensión suave (priorizar extensión) • pronosupinación controlada

Fortalecimiento inicial	6-8 semanas	• Mejorar fuerza muscular • Recuperar estabilidad articular	Ejercicios isométricos de flexores y extensores, banda elástica (Theraband), ejercicios de prensión con pelota terapéutica, trabajo de estabilidad radiocarpiana
Fortalecimiento avanzado	8-10 semanas	Mejorar resistencia y coordinación	Ejercicios resistidos progresivos, trabajo excéntrico de extensores, ejercicios propioceptivos
Reintegración funcional	10-12 semanas	Retorno a actividades laborales/deportivas	Ejercicios funcionales específicos, carga progresiva, ejercicios con patrones de movimiento funcionales según actividades del paciente

TRATAMIENTO FISIOTERAPEUTICO **FRACTURA DE SMITH**

INTERVENCIÓN A LA FISIOTERAPIA

A detailed X-ray image of a human hand and forearm, showing the bones of the wrist, radius, ulna, and the metacarpals and phalanges of the fingers. The image is in grayscale and has a slightly blurred, artistic quality.

GRACIAS POR SU ATENCIÓN